



Plano de Estudos Avançado

Introdução à Enfermagem — Aprendizagem Acelerada para EAD

 **Foco em Conceitos & Resultados**

 10 sessões × 2h30

 EN_430 — CH: 120h

 EAD / Subsequente

 Revisões de 30 min



Contexto da Disciplina — EAD com Enriquecimento Digital

Esta disciplina é ofertada na **modalidade EAD** (Ensino a Distância) para o **Curso de Enfermagem** (Subsequente). Você terá acesso a:

 **Material Escrito (PDF)**



Videoaulas Gravadas



Slides das Aulas



Fórum de Discussão



Questionários Online



Enquete para Aula Prática

Disciplina eletiva aberta aos alunos do 4º módulo — você já tem bagagem para elencar esta disciplina e conhece as dificuldades. Este plano foi desenhado para **maximizar seu aprendizado no menor tempo possível**, respeitando a flexibilidade do EAD mas com a **rigorosa estrutura de uma aula presencial**.



Enquete para aulas práticas: Dependendo do resultado da enquete que será enviada, **aulas práticas presenciais/laboratório** poderão ser incorporadas ao cronograma para complementar os procedimentos que exigem simulação (cateterismos, curativos, administração de medicamentos, etc.). Fique atento ao AVA e ao fórum da disciplina!



Material Escrito

Slides + apostilas da disciplina



Videoaulas

Assista antes de cada sessão



Mapas Mentais

Visualize e conecte conceitos



Exercícios

Fixação ativa do conteúdo



Revisão 30min

Consolidação profunda



Resultados

Foco no que realmente importa

1



Teoria das Necessidades Básicas — Wanda Horta

Fundamentos

2h30



TEORIA — CONCEITOS ESSENCIAIS

Estude os **3 níveis de necessidades** propostos por Wanda Horta: **Psicobiológicas** (oxigenação, hidratação, nutrição, eliminação, sono, locomoção, cuidado corporal, integridade cutânea), **Psicossociais** (comunicação, interação social, lazer, segurança emocional, autoestima) e **Psicoespirituais** (crenças, valores, religiosidade, transcendência).

- ▶ **Hierarquia:** Relacione com Maslow — necessidades básicas primeiro
- ▶ **Aplicação:** Cada necessidade afetada gera um diagnóstico de enfermagem
- ▶ **Integralidade:** O ser humano é um todo — cuide de todos os níveis



APLICAÇÃO PRÁTICA — CONEXÃO COM A REALIDADE

Exercício 1: Liste 5 pacientes com necessidades psicobiológicas afetadas e proponha 2 intervenções de enfermagem para cada.

Exercício 2: Crie um **mapa mental** relacionando cada nível de necessidade com diagnósticos NANDA-I correspondentes.

Exercício 3: Em dupla virtual (fórum), discuta: "Qual a diferença entre necessidade psicossocial e psicoespiritual? Dê exemplos reais."



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

- ▶ **Questão 1:** Quais são os 3 níveis da Teoria das Necessidades Básicas? Dê 3 exemplos de cada.
- ▶ **Questão 2:** Explique a relação entre a Teoria de Wanda Horta e a Pirâmide de Maslow.
- ▶ **Questão 3:** Um paciente pós-AVE apresenta hemiparesia e dificuldade para se alimentar. Quais necessidades estão afetadas?
- ▶ **Questão 4:** Como a integralidade do cuidado se aplica na prática? Dê um exemplo.



RECURSOS EAD PARA ESTA SESSÃO

Material escrito

Capítulo 1 do Guia Completo de Estudos (Módulo 1)

Vídeo

"Teoria das

Necessidades Humanas Básicas - Wanda Horta" no YouTube

Slides

Slides da aula 1 da

disciplina no AVA

**Mapa Mental**

Consulte o Mapa Mental dos 10 Módulos

**SESSÃO DE REVISÃO — 30 MINUTOS** **CRÍTICO**

Explique em voz alta (10 min): Feche os olhos e recite os 3 níveis de necessidades com pelo menos 3 exemplos de cada. Imagine que está explicando para um colega de turma no fórum da disciplina.

Esquematize (10 min): Em uma folha em branco, desenhe um **diagrama** conectando: Wanda Horta → 3 níveis → Exemplos → Diagnósticos de Enfermagem.

Autoavaliação (10 min): Responda rápido: "Quais 5 necessidades psicobiológicas eu lembro de cabeça? E 3 psicossociais? E 2 psicoespirituais?"

✓ **Resultado esperado:** Você deve ser capaz de listar os 3 níveis e dar exemplos sem consultar o material

✓ **Indicador de sucesso:** Conseguiu explicar para si mesmo sem travar? Se sim, avançou!

Foco em resultados: Ao final desta sessão, você será capaz de **identificar necessidades**



básicas afetadas em qualquer paciente e **relacioná-las a diagnósticos de enfermagem** — a base de todo o cuidado!

2

**SAE — Sistematização da Assistência de Enfermagem****Fundamentos** **2h30****TEORIA — AS 5 ETAPAS DA SAE**

A **SAE** é o método científico da enfermagem, regulamentada pela **Resolução COFEN 358/2009**. As 5 etapas são:

- ▶ ① **Histórico de Enfermagem:** Coleta de dados (entrevista + exame físico) — o "raio-X" do paciente
- ▶ ② **Diagnóstico de Enfermagem:** Julgamento clínico baseado na taxonomia NANDA-I
- ▶ ③ **Planejamento:** Definição de resultados esperados (NOC) e intervenções (NIC)
- ▶ ④ **Implementação:** Execução das intervenções de enfermagem planejadas
- ▶ ⑤ **Avaliação:** Verificação se os resultados foram alcançados (feedback)

**APLICAÇÃO PRÁTICA — CASO CLÍNICO GUIADO**

Cenário: Paciente Sr. José, 72 anos, pós-operatório de artroplastia de quadril, apresenta dor moderada (6/10), dificuldade para movimentar-se e ansiedade quanto à recuperação.

Aplique as 5 etapas da SAE:

- ▶ **Histórico:** Que dados você coletaria na admissão?
- ▶ **Diagnóstico:** Qual(is) diagnóstico(s) NANDA-I? (ex: "Mobilidade física prejudicada")
- ▶ **Planejamento:** Qual resultado NOC esperar? Quais intervenções NIC?
- ▶ **Implementação:** Descreva 3 intervenções que você executaria
- ▶ **Avaliação:** Como saber se o paciente melhorou?

**EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO**

- ▶ **Questão 1:** Quais são as 5 etapas da SAE em ordem? Crie um mnemônico (ex: HDPIA).
- ▶ **Questão 2:** Qual a base legal da SAE? Explique a importância da Resolução COFEN.
- ▶ **Questão 3:** Diferencie NANDA-I, NIC e NOC. Qual a função de cada um na SAE?
- ▶ **Questão 4:** A SAE é privativa do enfermeiro? Explique o papel da equipe de enfermagem.

**RECURSOS EAD PARA ESTA SESSÃO**

 **Material escrito** Guia Completo — Módulo 2 (SAE)  **Vídeo** Playlist "Processo de Enfermagem NANDA NIC NOC" — Descomplica Enfermagem  **Slides** Slides da aula 2 da disciplina  **PDF** Resolução COFEN 358/2009 (consulte no AVA)

**SESSÃO DE REVISÃO — 30 MINUTOS** **CRÍTICO**

 **Recitação em voz alta (10 min):** Feche os olhos e recite as 5 etapas da SAE em ordem. Para cada etapa, dê uma frase curta explicando o que acontece.

 **Fluxograma (10 min):** Desenhe um fluxograma da SAE com as 5 etapas, incluindo um exemplo concreto de cada (baseado no caso do Sr. José).

 **Autoavaliação (10 min):** Sem olhar o material: quantas etapas você lembra? Consegue explicar NANDA vs NIC vs NOC? Teste-se!

✓ **Resultado esperado:** Você domina as 5 etapas da SAE e sabe aplicar a um caso clínico

✓ **Mnemônico útil:** HDPIA — "Hoje, Diagnóstico, Planejamento, Implementação, Avaliação"

Foco em resultados: A SAE é o **método científico da enfermagem**. Dominá-la significa pensar



como um enfermeiro — não apenas executar tarefas, mas **planejar, implementar e avaliar o cuidado!**

3



Anotação de Enfermagem + Terminologias Técnicas

Documentação

 2h30

TEORIA — REGISTRO DE ENFERMAGEM

A **anotação de enfermagem** é o registro escrito de todas as observações, cuidados e procedimentos realizados com o paciente. Princípios fundamentais:

- ▶ **Objetividade:** Fatos, não opiniões. "Paciente refere dor 6/10" e não "Paciente está com dor"
- ▶ **Clareza:** Letra legível (ou digital), termos técnicos corretos, sem rasuras
- ▶ **Cronologia:** Data e hora em cada registro
- ▶ **Completude:** Tudo que foi observado, feito e avaliado
- ▶ **Sigilo:** Prontuário é documento legal e sigiloso



APLICAÇÃO PRÁTICA — ESCRREVENDO ANOTAÇÕES

Exercício 1: Analise a anotação abaixo e corrija os erros:

"Paciente estava meio ruim hoje. Acho que não dormiu bem. Fez xixi normalmente. Enfermeira Maria."

Exercício 2: Reescreva a anotação acima de forma técnica e objetiva.

Exercício 3: Escreva anotações para 3 situações: admissão, evolução diária e alta.



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO — TERMINOLOGIAS

Associe o termo técnico ao significado:

- ▶ Afebril ↔ Temperatura normal (sem febre)
- ▶ Normocárdico ↔ Frequência cardíaca normal (60-100 bpm)
- ▶ Eupneico ↔ Respiração normal (16-20 irpm)
- ▶ Normotenso ↔ Pressão arterial normal (120/80 mmHg)
- ▶ Anictérico ↔ Sem icterícia (pele sem coloração amarelada)
- ▶ Normocorado ↔ Coloração normal da pele e mucosas
- ▶ Lúcido e Orientado ↔ Consciente, responde a comandos verbais
- ▶ Diurese presente ↔ Volume urinário dentro da normalidade



RECURSOS EAD PARA ESTA SESSÃO

 **Material escrito** Guia Completo — Módulo 3 (Anotação + Glossário)  **Vídeo** "Como fazer anotação de enfermagem" no YouTube  **Slides** Slides da aula 3 com exemplos de prontuários  **PDF** Glossário de terminologias técnicas



SESSÃO DE REVISÃO — 30 MINUTOS **CRÍTICO**

 **Explique o método SOAP (10 min):** S = Subjetivo (o que o paciente diz), O = Objetivo (o que você observa/mede), A = Avaliação (seu julgamento), P = Plano (próximos passos).

 **Escreva 2 anotações completas (10 min):** Use o formato SOAP para dois pacientes hipotéticos diferentes.

 **Autoavaliação (10 min):** Liste 10 terminologias e seus significados sem consultar o material. Quantas acertou?

✓ **Resultado esperado:** Você sabe escrever uma anotação técnica e objetiva usando terminologias corretas

✓ **Erro comum:** NUNCA use "paciente estava bem" — seja específico!



Foco em resultados: A anotação de enfermagem é **documento legal** que protege você e o paciente. Uma anotação mal feita pode custar seu registro profissional!

4



Administração de Medicamentos — Vias Enterais

Medicação

 2h30

TEORIA — OS 7 CERTOS E VIAS ENTERAIS



Os 7 Certos da Administração de Medicamentos:

- ▶ ① **Paciente certo** — confira nome completo + identificação (pulseira)
- ▶ ② **Medicamento certo** — compare com a prescrição médica
- ▶ ③ **Dose certa** — calcule e confira (regra de três!)
- ▶ ④ **Via certa** — enteral (VO, SL, sonda) vs parenteral (ID, SC, IM, EV)
- ▶ ⑤ **Horário certo** — respeite o intervalo prescrito
- ▶ ⑥ **Registro certo** — anote IMEDIATAMENTE após administrar
- ▶ ⑦ **Orientação certa** — informe o paciente sobre o medicamento

Vias Enterais: Oral (VO), Sublingual (SL), Sonda Nasogástrica (SNG) e Sonda Enteral (SNE).



APLICAÇÃO PRÁTICA — CÁLCULOS E PREPARO

- ▶ **Cálculo 1:** Prescrição: 500mg de Amoxicilina VO. Disponível: comprimidos de 250mg. Quantos comprimidos administrar?
- ▶ **Cálculo 2:** Prescrição: 20mg de Omeprazol por SNG. Disponível: 40mg/5mL. Quantos mL?
- ▶ **Cálculo 3:** Prescrição: Soro Fisiológico 0,9% 500mL em 8h. Qual o gotejamento? (gotas/min = volume / (tempo×3))
- ▶ **Prática:** Simule o preparo de 3 medicações para administrar por sonda (diluição, trituração, compatibilidade)

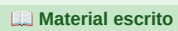


EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

- ▶ **Questão 1:** Cite os 7 Certos na ordem correta. Crie um mnemônico!
- ▶ **Questão 2:** Qual a diferença entre via enteral e parenteral? Dê exemplos de cada.
- ▶ **Questão 3:** Por que a via sublingual tem absorção mais rápida que a via oral?
- ▶ **Questão 4:** Quais cuidados ao administrar medicamentos por sonda nasogástrica?



RECURSOS EAD PARA ESTA SESSÃO



Guia Completo — Módulo 4



"13 Certos na Administração de

Medicamentos" + "Cálculo de Medicamentos"



Slides da aula 4 com tabela de vias



MedCalc para praticar cálculos



SESSÃO DE REVISÃO — 30 MINUTOS

CRÍTICO



Recite os 7 Certos (5 min): P M D V H R O — sem olhar!



Resolva 3 cálculos (10 min): Regra de três, gotejamento, diluição.



Esquematize (10 min): Desenhe uma tabela comparativa: Via Enteral → Exemplos
→ Cuidados → Absorção.



Autoavaliação (5 min): Você consegue explicar os 7 Certos para um colega?



Resultado esperado: Você sabe os 7 Certos, sabe calcular doses e entende as vias enterais



Mnemônico: "Paciente, Medicamento, Dose, Via, Horário, Registro, Orientação"



Foco em resultados: Erro de medicação é a **causa mais comum de eventos adversos** em hospitais. Os 7 Certos são sua **barreira de segurança** — memorize-os como seu nome!

5

**Vias Parenterais + Cálculo de Medicamentos**

Medicação

⌚ 2h30

**TEORIA — VIAS PARENTERAIS**

As **4 vias parenterais** (fora do trato digestivo) que todo enfermeiro precisa dominar:

- ▶ **ID (Intradérmica):** 10–15° | 0,5 mL máximo | Face anterior do antebraço | PPD, BCG, testes alérgicos
- ▶ **SC (Subcutânea):** 45–90° | 1–2 mL | Abdômen, braço, coxa | Insulina, heparina, vacinas
- ▶ **IM (Intramuscular):** 90° | 3–5 mL (adulto) | Deltoide (2mL), Vasto lateral (5mL), Glúteo (4mL) | Benzetacil, dipirona, AAS
- ▶ **EV (Endovenosa):** 25–45° | Variável | Veias do antebraço, mão | Soros, antibióticos, quimioterápicos

**APLICAÇÃO PRÁTICA — TABELA COMPARATIVA E CASOS**

- ▶ **Tabela:** Crie uma tabela com: Via → Ângulo → Volume Máximo → Local → Exemplo de Medicamento → Agulha
- ▶ **Caso 1:** Prescrição: Heparina SC. Qual o local? Qual ângulo? Qual agulha?
- ▶ **Caso 2:** Prescrição: Dipirona 2mL IM. Qual o melhor local? Volume máximo? Cuidados?
- ▶ **Caso 3:** Calcule: Prescrição de 250mg de Ampicilina EV. Frasco de 500mg — diluir em 5mL. Quantos mL administrar?

**EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO**

- ▶ **Questão 1:** Qual o ângulo de cada via parenteral? (ID: 15°, SC: 45°, IM: 90°, EV: 25–45°)
- ▶ **Questão 2:** Qual o volume máximo para ID? E para IM no deltoide?
- ▶ **Questão 3:** Por que a via EV tem absorção mais rápida que a IM?
- ▶ **Questão 4:** Quais cuidados ao administrar Benzetacil IM (glúteo)?
- ▶ **Questão 5:** Cálculo: Administrar 300mg de Amicacina. Disponível: 500mg/2mL. Quantos mL?

**RECURSOS EAD PARA ESTA SESSÃO**

 **Material escrito** Guia Completo — Módulo 4 (vias parenterais)  **Vídeo** "Vias de Administração Parenteral" — YouTube  **Slides** Slides da aula 5 com fotos de locais de aplicação  **PDF** Tabela completa: agulhas × vias × volumes

**SESSÃO DE REVISÃO — 30 MINUTOS** **CRÍTICO**

 **Recitação (10 min):** "ID 15° 0,5mL antebraço — SC 45° 2mL abdômen — IM 90° 5mL glúteo — EV 30° variável antebraço". Repita 3x!

 **Cálculos (10 min):** Resolva 5 questões de cálculo de medicamentos (regra de três e gotejamento).

 **Mapa mental (10 min):** Desenhe um esquema com as 4 vias, ângulos, locais e volumes máximos.

✓ **Resultado esperado:** Você diferencia as 4 vias parenterais e sabe qual usar em cada situação

✓ **Regra dos ângulos:** "15-45-90: quanto mais profundo, maior o ângulo"

Foco em resultados: Escolher a via errada ou administrar no local errado pode causar **lesões**



graves (lesão de nervo ciático na IM glútea, necrose na SC). Domine as vias para garantir a **segurança do paciente!**

6



Assepsia, Antissepsia, Higiene e Conforto do Paciente

Segurança

 2h30

TEORIA — CONTROLE DE INFECÇÃO

- ▶ **Assepsia:** Ausência total de microrganismos (campo estéril, sala cirúrgica)
- ▶ **Antissepsia:** Redução de microrganismos na pele (álcool 70%, PVPI, clorexidina)
- ▶ **Degermação:** Lavagem das mãos com água e sabão (remoção mecânica)
- ▶ **5 Momentos da Higienização das Mãos (OMS):**
 1. ▶ Antes de tocar o paciente
 2. ▶ Antes de procedimento limpo/asséptico
 3. ▶ Após risco de exposição a fluidos corporais
 4. ▶ Após tocar o paciente
 5. ▶ Após tocar superfícies próximas ao paciente



APLICAÇÃO PRÁTICA — TÉCNICAS

- ▶  **Lavagem das mãos:** Descreva o passo a passo (molhar → sabão → esfregar 20s → enxaguar → secar)
- ▶  **Luvas estéreis:** Sequência correta para calçar sem contaminar (toque apenas no punho)
- ▶  **Banho no leito:** Passos: material → segurança → privacidade → técnica (cabeça → tórax → abdômen → MMSS → MMII → dorso → períneo)
- ▶  **Mudança de decúbito:** A cada 2 horas para prevenir lesão por pressão (LPP)



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

- ▶ **Questão 1:** Diferença entre assepsia e antissepsia? Dê exemplos de cada.
- ▶ **Questão 2:** Quais os 5 momentos da higienização das mãos? (recite em ordem!)
- ▶ **Questão 3:** Qual a sequência correta para calçar luvas estéreis?
- ▶ **Questão 4:** Quais os cuidados para prevenir lesão por pressão durante o banho no leito?



RECURSOS EAD PARA ESTA SESSÃO

 **Material escrito** Guia Completo — Módulo 5  **Vídeo** "Higienização das Mãos OMS" + "Calçar luvas estéreis" + "Banho no leito"  **Slides** Slides da aula 6 com protocolos ANVISA



Protocolo de Segurança do Paciente (ANVISA)

**SESSÃO DE REVISÃO — 30 MINUTOS****CRÍTICO**

Simulação guiada (15 min): Feche os olhos e **simule mentalmente** cada passo: lavagem das mãos (esfregue as mãos enquanto recita os passos) → calçar luvas estéreis (imagine cada movimento) → banho no leito (visualize a sequência).



Checklist (10 min): Escreva um checklist de 10 itens para garantir a segurança do paciente durante o banho no leito.



Autoavaliação (5 min): Você sabe os 5 momentos da OMS? Consegue recitá-los?



Resultado esperado: Você sabe a sequência completa de higiene e segurança do paciente



Dica: "Antes do paciente, Antes do procedimento, Após fluido, Após paciente, Após ambiente"



Foco em resultados: A **infecção hospitalar** é um dos maiores problemas de saúde pública. A higienização das mãos é a **medida mais eficaz** para preveni-la — salva vidas!

7



Curativos, Feridas e Coberturas Especiais

Procedimentos

2h30



TEORIA — CLASSIFICAÇÃO DE FERIDAS E COBERTURAS

Classificação de feridas:

- ▶ **Quanto à causa:** Cirúrgica, traumática, ulcerativa (LPP), por queimadura
- ▶ **Quanto à contaminação:** Limpa, limpa-contaminada, contaminada, infectada
- ▶ **Quanto ao tempo:** Aguda (até 6 semanas) vs Crônica (> 6 semanas)
- ▶ **Quanto à profundidade:** Estágio 1 (pele íntegra) a Estágio 4 (osso/músculo exposto)

Coberturas especiais:

- ▶ **Hidrocoloide:** Feridas secas a pouco exsudativas — troca a cada 3-5 dias
- ▶ **Alginato de cálcio:** Feridas muito exsudativas — absorve 20x seu peso
- ▶ **Carvão ativado com prata:** Feridas infectadas com odor — ação antibacteriana
- ▶ **Espuma de poliuretano:** Feridas moderadamente exsudativas — conforto e absorção
- ▶ **Filme transparente:** Proteção de pele íntegra, cobertura de cateteres



APLICAÇÃO PRÁTICA — ESCOLHA DA COBERTURA

- ▶ **Caso 1:** Ferida cirúrgica limpa, pós-operatório imediato, sem exsudato. Qual cobertura?
- ▶ **Caso 2:** LPP estágio 3 no sacro, muito exsudato, sem infecção. Qual cobertura?
- ▶ **Caso 3:** Ferida oncológica infectada, com odor fétido. Qual cobertura?
- ▶ **Caso 4:** Descrição do passo a passo do curativo de ferida cirúrgica (técnica estéril)



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

- ▶ **Questão 1:** Classifique uma ferida: cirúrgica, limpa, com 4 dias de pós-operatório.
- ▶ **Questão 2:** Qual cobertura usar para ferida exsudativa? E para ferida com odor?
- ▶ **Questão 3:** Diferença entre curativo convencional e cobertura especial?
- ▶ **Questão 4:** Quais os estágios de lesão por pressão? Caracterize cada um.



RECURSOS EAD PARA ESTA SESSÃO

 **Material escrito** Guia Completo — Módulo 6  **Vídeo** "Você Tem Obrigação de Conhecer Esses Curativos!" — Descomplica Enfermagem  **Slides** Slides da aula 7 com fotos de feridas e coberturas  **PDF** Guia de Coberturas do Ministério da Saúde

**SESSÃO DE REVISÃO — 30 MINUTOS** **CRÍTICO**

 **Classifique em voz alta (10 min):** Para cada cobertura, recite: nome → indicação → tipo de ferida → tempo de troca.

 **Quadro-resumo (10 min):** Desenhe uma tabela: Cobertura | Indicação | Exsudato | Tempo de troca.

 **Caseando (10 min):** Resolva 3 casos clínicos de escolha de cobertura (use os casos da seção prática).

✓ **Resultado esperado:** Você sabe classificar feridas e escolher a cobertura adequada para cada caso

✓ **Dica:** Ferida seca → hidrocoloide; Ferida úmida → alginato; Ferida infectada → carvão+prata



Foco em resultados: A escolha correta da cobertura **acelera a cicatrização** em até 50% e reduz o risco de infecção. Uma ferida mal cuidada pode levar a **sepse e amputação!**

8



Oxigenoterapia + Cateterismos (Vesical, Gástrico, Entérico, Retal)

Procedimentos

🕒 2h30



TEORIA — SUPORTE VENTILATÓRIO E CATETERISMOS

Oxigenoterapia — Dispositivos:

- ▶ **Cateter Nasal (CN):** 1–5 L/min | FiO₂ 24–40% | Baixo fluxo
- ▶ **Máscara Simples:** 5–10 L/min | FiO₂ 35–50% | Baixo fluxo
- ▶ **Máscara de Venturi:** Fluxo exato, FiO₂ controlada 24–50% | Alto fluxo
- ▶ **Máscara c/ Reservatório (NRB):** 10–15 L/min | FiO₂ 60–95% | Urgência

Cateterismos:

- ▶ **SNG:** Descompressão gástrica, lavagem gástrica, coleta de conteúdo
- ▶ **SNE:** Administração de dieta e medicamentos
- ▶ **Sonda Vesical (Alívio/Demora):** Esvaziamento vesical, controle de diurese, coleta estéril
- ▶ **Sonda Retal:** Eliminação de gases (flatos) e fecaloma



APLICAÇÃO PRÁTICA — TABELA COMPARATIVA

- ▶ **Tabela de O₂:** Dispositivo | Fluxo | FiO₂ | Indicação | Cuidados
- ▶ **Tabela de Cateterismos:** Tipo | Indicação | Material | Cuidados Pré | Cuidados Pós | Complicações
- ▶ **Simulação:** Descreva o preparo do paciente para: SNG (dieta), SVD (diurese), Sonda retal (fecaloma)
- ▶ **Destaque:** 3 complicações de cada procedimento e como preveni-las

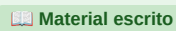


EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

- ▶ **Questão 1:** Qual dispositivo de O₂ usar para FiO₂ exata de 35%? E para 90%?
- ▶ **Questão 2:** Diferença entre SNG e SNE? Indicações de cada.
- ▶ **Questão 3:** Quais cuidados ao realizar cateterismo vesical de demora feminino?
- ▶ **Questão 4:** Quais as complicações mais comuns de cada tipo de cateterismo?



RECURSOS EAD PARA ESTA SESSÃO



Guia Completo — Módulo 7



"Oxigenoterapia - Dispositivos" +

"Sondagem Vesical" + "SNG e SNE"



Slides da aula 8



Protocolos de

Cateterismo do Ministério da Saúde



SESSÃO DE REVISÃO — 30 MINUTOS

CRÍTICO



Compare os procedimentos (10 min): Explique em voz alta as diferenças entre: SNG (descompressão/lavagem) vs SNE (dieta) vs Sonda vesical (diurese) vs Sonda retal (gases).



Tabela dupla (10 min): Desenhe a tabela de oxigenoterapia (fluxo + FiO_2) e a tabela de cateterismos (indicações + complicações).



Autoavaliação (10 min): Para cada procedimento, recite: 1 indicação, 1 cuidado essencial, 1 complicação.



Resultado esperado: Você sabe qual dispositivo de O_2 escolher e domina as indicações dos 4 cateterismos



Macete: "Quanto maior a necessidade de O_2 , maior o fluxo e a FiO_2 "



Foco em resultados: Cateterismos são procedimentos **invasivos** com risco de infecção. Cada tipo tem **técnica, indicação e cuidados específicos** — confundir SNG com SNE pode ser fatal!

9

Exames, Coletas, Medidas Antropométricas, Crioterapia e Termoterapia

Procedimentos

🕒 2h30



TEORIA — COLETAS E MEDIDAS

Coletas de exames:

- ▶ **Sangue (hemograma):** Punção venosa — torniquete, assepsia, agulha 25x7, frasco a vácuo, ordem dos tubos
- ▶ **Urina:** Jato médio (1º jato descarta), urina 24h (início da manhã), urocultura (jato médio, frasco estéril)
- ▶ **Fezes:** Parasitológico (3 amostras), sangue oculto (dieta específica)
- ▶ **Escarro:** Matinal, jejum, lavagem brônquica

Medidas Antropométricas:

- ▶ **Peso:** Balança calibrada, paciente descalço, roupas leves
- ▶ **Altura:** Estadiômetro, posição ereta, olhar no horizonte
- ▶ **IMC:** $\text{Peso (kg)} / \text{Altura}^2 \text{ (m)}$ | Classificação: <18,5 (magreza) | 18,5-24,9 (normal) | 25-29,9 (sobrepeso) | ≥ 30 (obesidade)
- ▶ **C. Abdominal:** Fita no ponto médio entre costela e crista ilíaca

Crioterapia ❄️ (frio): Bolsa de gelo 20 min — edema agudo, dor, processo inflamatório inicial

Termoterapia 🔥 (calor): Bolsa de água quente 20 min — contraturas, abscesso, dor crônica, processo inflamatório tardio



APLICAÇÃO PRÁTICA — CHECKLIST E CÁLCULOS

- ▶ **Checklist:** Crie uma lista de verificação para coleta de: sangue (jejum? frasco? prazo?), urina 24h, fezes, escarro
- ▶ **Calcule o IMC:** 5 exemplos e classifique cada um (ex: $70\text{kg}/1,75\text{m} = 22,9$ — normal)
- ▶ **Comparativo:** Crioterapia vs Termoterapia: quando usar cada? 3 indicações e 3 contraindicações de cada



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

- ▶ **Questão 1:** Calcule e classifique: $65\text{kg} / 1,60\text{m}$. E $90\text{kg} / 1,75\text{m}$?
- ▶ **Questão 2:** Qual a diferença entre coleta de urina para urocultura e urina 24h?

- ▶ **Questão 3:** Quando usar crioterapia? E termoterapia? Dê exemplos.
- ▶ **Questão 4:** Quais os cuidados na coleta de sangue venoso? (ordem dos tubos?)

**RECURSOS EAD PARA ESTA SESSÃO**

 **Material escrito** Guia Completo — Módulo 8  **Vídeo** "Técnica de punção venosa" + "Medidas Antropométricas"  **Slides** Slides da aula 9  **PDF** Tabela de IMC (OMS) + Guia de coleta de exames

**SESSÃO DE REVISÃO — 30 MINUTOS** **CRÍTICO**

 **Cálculos de IMC (10 min):** Calcule e classifique 5 IMCs diferentes. Memorize os pontos de corte!

 **Checklist de coleta (10 min):** Escreva o passo a passo para coleta de sangue, urina e fezes.

 **Comparativo (10 min):** Recite as indicações e contraindicações de crioterapia e termoterapia.

✓ **Resultado esperado:** Você sabe calcular IMC, preparar paciente para coletas e escolher entre frio/calor

✓ **Dica:** "Frio para agudo, Calor para crônico" — crioterapia nos primeiros 48h, termoterapia após



Foco em resultados: Uma coleta mal feita = **resultado falso** = diagnóstico errado = tratamento errado. A precisão na coleta é **responsabilidade direta da enfermagem!**

10

 Admissão, Alta, Contenção, Cama Hospitalar, Pós-Morte + Revisão**Final** **Fechamento** **2h30****TEORIA — PROCESSOS HOSPITALARES****Admissão do paciente:**

- ▶ **Identificação:** Nome completo, pulseira de identificação, leito
- ▶ **Acolhimento:** Apresentar a equipe, orientar sobre rotinas, direitos
- ▶ **Coleta de dados:** Sinais vitais, histórico, queixa principal, medicações em uso
- ▶ **Pertences:** Guardar objetos de valor, orientar sobre pertences pessoais

Tipos de contenção:

- ▶ **Mecânica:** Faixas (punho, tórax, joelhos) — último recurso, prescrição médica
- ▶ **Química:** Sedação medicamentosa — avaliação médica contínua
- ▶ **Ambiental:** Grades de proteção, cama baixa, supervisão constante

Processo pós-morte: Declaração de óbito (médico) → Preparo do corpo (higiene, identificação, posição decúbito dorsal, algodão nos orifícios) → Aspectos legais e éticos
→ Apoio à família

**APLICAÇÃO PRÁTICA — CHECKLISTS E SIMULAÇÃO**

- ▶ **Checklist de Admissão:** Crie 10 itens essenciais para receber um paciente no setor
- ▶ **Checklist de Alta:** Crie 8 itens para garantir uma alta segura
- ▶ **Simulação de contenção:** Descreva a técnica de contenção mecânica — indicações, cuidados de 1 em 1h, liberação a cada 2h
- ▶ **Pós-morte:** Descreva o passo a passo do preparo do corpo com respeito e técnica

**EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO + REVISÃO FINAL**

- ▶ **Questão 1:** Quais os passos da admissão do paciente? O que não pode faltar?
- ▶ **Questão 2:** Quais os 3 tipos de contenção? Quando usar cada uma?
- ▶ **Questão 3:** Descreva o preparo do corpo pós-morte (ordem dos passos).
- ▶ **Questão 4 (Revisão):** Recite os 7 Certos, as 5 etapas da SAE e a classificação de feridas
- ▶ **Questão 5 (Revisão):** Quais os 5 momentos da higienização das mãos?

**RECURSOS EAD PARA ESTA SESSÃO** **Material escrito**

Guia Completo — Módulos 9 e 10 + Glossário

Vídeo

"Admissão de

Pacientes" + "Contenção Mecânica" + "Processo Pós-Morte"

Slides

Slides da aula 10

PDF

Protocolos institucionais de admissão e alta

**REVISÃO FINAL — 30 MINUTOS** **ULTRA IMPORTANTE**

Grand Tour (15 min): Recite TODOS os conceitos essenciais da disciplina em sequência: Necessidades Básicas (3 níveis) → SAE (5 etapas) → Anotação (SOAP) → 7 Certos + Vias Parenterais (ID/SC/IM/EV) → Assepsia/Antissepsia (5 momentos) → Curativos (coberturas) → Oxigenoterapia (dispositivos) → Cateterismos (4 tipos) → IMC (classificação) → Crioterapia/Termoterapia → Admissão/Alta → Pós-Morte.



Autoavaliação escrita (10 min): Sem consultar nada, escreva em uma folha tudo que você lembra de cada módulo. Depois compare com o Resumo de 5 Minutos.



Checklist final (5 min): Marque os tópicos que você domina e identifique 2-3 pontos fracos para revisar antes da prova.



Resultado esperado: Você é capaz de explicar todos os 10 módulos da disciplina de forma integrada



Próximo passo: Resolva os 20 exercícios de fixação do Guia Completo e os 35 dos Casos Clínicos!

Foco em resultados: Você completou as **25 horas** de estudo intensivo! Agora você tem a **base sólida** para a disciplina de Introdução à Enfermagem. Pratique com os Casos Clínicos e revise com os Flashcards!

**Seu Progresso nas 10 Sessões**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Marque cada sessão como concluída ao finalizar a revisão de 30 minutos



10 sessões × 2h30 = **25 horas totais**



5 horas dedicadas à revisão (30 min × 10)



80% teoria/prática + 20% revisão = aprendizagem duradoura



Disciplina EAD — EN_430 · Curso de Enfermagem (Subsequente) · Material organizado por **Vânia** ·

Julho 2026

🕒 Revisões de 30 minutos baseadas no princípio de **recuperação ativa** — o método mais eficaz para transferir conhecimento da memória de curto prazo para a memória de longo prazo.